

PERSPECTIVA INOVADORA NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: CARACTERIZAÇÃO DO AMOR PATOLÓGICO E SUA TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL NA PÓS-MODERNIDADE¹

*INNOVATIVE PERSPECTIVE IN PSYCHOSOCIAL CARE: CHARACTERIZATION OF
PATHOLOGICAL LOVE AND ITS INTERGENERATIONAL TRANSMISSION IN POST-MODERNITY*

Luciana Gomes Martins¹

¹Faculdade Irecê, Irecê – BA.

RESUMO: De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-IV de 2003, o transtorno de apego reativo na infância pode ser definido como um tipo de apego social marcadamente disruptivo e inapropriado para o desenvolvimento na maioria dos contextos, começando antes dos cinco anos de idade. Trata-se de um tipo de apego inseguro comum na infância que leva a relacionamentos desadaptativos na vida adulta, resultando nos vários casos, reconhecidos pelo senso comum tradicional, de pessoas que são devastadas pela dor originada de relacionamentos amorosos, chegando a morrer de imenso sofrimento, além dos casos de amantes rejeitados que são capazes de fazer coisas tolas ou perigosas, tanto para si mesmo quanto para os outros. Este artigo realiza uma discussão teórica sobre o conceito de Amor Patológico (AP), buscando estabelecer sua definição o mais claramente possível, através de revisão narrativa da literatura, visando estabelecer conceitos que auxiliem o trabalho dos profissionais de saúde envolvidos na atenção psicossocial e no atendimento de urgência.

Palavras-Chave: Amor Patológico; Transmissão Geracional/Intergeracional; Atenção Psicossocial.

ABSTRACT: According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV of 2003, reactive attachment disorder in childhood can be defined as a type of social attachment that is markedly disruptive and inappropriate for development in most contexts, beginning before the age of five. It is a type of insecure attachment common in childhood that leads to maladaptive relationships in adulthood, resulting in the various cases, recognized by traditional common sense, of people who are devastated by the pain originating from romantic relationships, even dying from immense suffering, in addition to cases of rejected lovers who are capable of doing foolish or dangerous things, both to themselves and to others. This article presents a theoretical discussion on the concept of Pathological Love (PL), seeking to establish its definition as clearly as possible through a narrative literature review, aiming to establish concepts that assist the work of health professionals involved in psychosocial care and emergency care.

Keywords: Pathological Love; Generational/Intergenerational Transmission; Psychosocial Care.

INTRODUÇÃO

O amor, em suas múltiplas formas, é frequentemente retratado como uma força positiva e transformadora. No entanto, quando disfuncional ou patológico, as relações amorosas podem gerar sofrimento psicológico severo, impactando não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também ramificando-se por gerações. A caracterização do amor patológico — marcado por dependência

¹ O presente artigo é resultado das pesquisas da autora no âmbito de seu doutoramento.

emocional, ciúmes obsessivo-retrospectivos, controle excessivo e abuso emocional — torna-se, assim, uma problemática social e clínica de grande relevância. Compreender a sua transmissão intergeracional é crucial para elaborar estratégias de prevenção, intervenção terapêutica e políticas públicas de saúde mental.

A urgência de investigar tais dinâmicas se justifica pelos altos índices globais de sofrimento psicológico relacionados a conflitos íntimos. Segundo dados recentes da Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais ao redor do mundo (OPAS, 2025). Embora esse número englobe diversas condições (como depressão e ansiedade), ele sugere a magnitude do problema e a necessidade de considerar as relações afetivas como parte significativa do panorama (MOITRA et al., 2023).

Estudos concretos demonstram que problemas no relacionamento íntimo são uma causa substancial de sofrimento mental e até de desfechos fatais. Por exemplo, uma investigação que analisou 402.391 suicídios relatados no Sistema Nacional de Morte Violenta dos Estados Unidos entre 2003 e 2020 encontrou que 20% dessas mortes (equivalente a 80.717 casos) estavam relacionados a ‘problemas de parceiro íntimo’ (como separação, divórcio, brigas ou rompimentos) — fenômeno identificado como Intimate Partner Problems, IPP (STANLEY et al., 2023).

Além disso, a mesma análise destacou que esses suicídios associados a IPP eram mais frequentemente precedidos por histórico de diagnóstico psiquiátrico, ideação suicida ou tentativas anteriores, além de estressores como conflitos legais, financeiros e familiares (STANLEY et al., 2023).

O impacto psicológico de relacionamentos românticos disfuncionais também se manifesta em transtornos mentais sem necessariamente culminar em suicídio. Em uma revisão recente, identificou-se correlações robustas entre estresse relacional — especialmente nas formas de “distresse conjugal” — e depressão, sugerindo que a insatisfação afetiva é tão potente para o bem-estar psicológico quanto fatores tradicionalmente considerados de risco, como a educação, o gênero ou traumas infantis.

Além disso, ao se observar populações jovens, os conflitos em relacionamentos amorosos emergentes têm sido associados a sintomas depressivos e ansiedade. Um estudo com adultos jovens demonstrou que o conflito em namoros é positivamente correlacionado com depressão, reforçando a hipótese de que a qualidade relacional exerce papel central na saúde mental desde estágios iniciais da vida (NAIR; SINHA, 2023). Uma revisão mais ampla também aponta que relações românticas insatisfatórias — bem como o rompimento dessas — se relacionam com desfechos negativos na saúde mental de adolescentes e jovens adultos, incluindo redução da autoestima, instabilidade emocional e processos crônicos de estresse (NAVANEETHAM; KANTH, 2022).

Considerando a transmissão intergeracional, os efeitos de um amor patológico podem ultrapassar a experiência individual e afetar filhos e netos. Por exemplo, mães que passaram por múltiplas instabilidades relacionais (como “*relationship churning*”, ou seja, ciclos de separação e reconciliação) apresentam taxas mais elevadas de depressão e uso de serviços de saúde mental, segundo um estudo longitudinal (HALPERN-MEEKIN; TURNEY, 2022). Esses padrões sugerem que a perturbação do vínculo amoroso pode moldar estratégias de apego, regulação emocional e padrões de relacionamento nas gerações seguintes.

Ainda que existam lacunas na literatura específica sobre “amor patológico” enquanto constructo clínico consolidado, a evidência de relações entre instabilidade amorosa, sofrimento mental e mortalidade por suicídio reforça a importância de

abordar essa temática sob uma perspectiva sistêmica. A caracterização clara dos traços patológicos — como dependência, controle, intimidação emocional ou ciúme mal-adaptativo — e a investigação de como tais traços se perpetuam por meio de famílias são fundamentais para o avanço da pesquisa clínica e preventiva.

Portanto, este artigo, no âmbito da Psicologia Social, realiza uma discussão teórica acerca do conceito de Amor Patológico (AP), em busca de esclarecer ao máximo essa temática de forma a disseminar seus parâmetros, conceitos e aplicações fundamentais, auxiliando o trabalho das equipes de atenção psicossocial que frequentemente precisam atender indivíduos com AP.

Através de uma revisão narrativa de literatura, o artigo pretende explorar de forma integrada os elementos constitutivos do amor patológico, os mecanismos de sua transmissão intergeracional, e as implicações para a saúde mental pública.

O texto está dividido em 7 seções, sendo esta Introdução, seguida pela Busca da Patologia na Relação Amorosa, pela Conceituação do Amor Patológico, pelos Padrões de Codependência, pelo Vício como Sintoma da Codependência, pela Busca de um Amor Saudável, pelas Considerações Finais, e pelas Referências.

EM BUSCA DA PATOLOGIA NA RELAÇÃO AMOROSA

Surge uma questão: onde reside a patologia da relação amorosa, senão no próprio ato de amar? Respondendo a isso, Freud afirma que: “*quando amamos, não o fazemos repetindo o encontro com o objeto fundamental, o objeto anterior ao limite incestuoso (substituído por outro)*” (Freud, 1910, p. 18). É perceptível que o sujeito “adoece” especificamente a partir do seu relacionamento amoroso familiar, dos seus primeiros relacionamentos e renúncias.

É evidente, então, que o drama reside no relacionamento amoroso familiar porque, desde o início da vida, o ser humano se encontra em um estado de completa dependência do outro. Inicialmente, essa dependência recai sobre a mãe, que é fundamental e detém poder.

Há traços desse período que o sujeito revive ao longo da vida, incluindo suas primeiras angústias. Cada sujeito se aproxima do outro para amar da maneira como subjugava a sexualidade vivenciada nas relações da infância.

Observa-se que o sofrimento e a patologia não surgem no momento em que o sujeito se apaixona, mas quando a relação se forma. “*Essa construção só é eficaz porque recupera um fragmento da experiência perdida*” (Freud, 1937, p. 303).

Surge então a questão: o que é o amor? É possível explicar esse termo inteiramente subjetivo em palavras?

CONCEITUANDO O AMOR PATOLÓGICO

Essa questão se levanta, apesar de tantos conceitos positivos que o cercam, quando a experiência de vida revela casos em que amar em excesso é considerado prejudicial à saúde.

Ou seja, quando há falta de controle e liberdade de escolha em relação ao ato de amar, a ponto de se tornar uma prioridade para o indivíduo — em detrimento de outros interesses antes valorizados — caracteriza-se um problema chamado Amor Patológico (AP) (Sophia et al., 2005).

Sophia et al. (2007) afirmam que relacionamentos românticos saudáveis são caracterizados pela preocupação com o cuidado e a atenção do parceiro. No entanto,

quando essas atitudes se tornam descontroladas, surge um problema conhecido como amor patológico (AP).

Isso pode estar associado a outros transtornos de ansiedade, como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e dependência afetiva; no entanto, um diagnóstico distinto é estabelecido para o amor patológico. Indivíduos com essa patologia comportam-se de maneira incontrolável e repetitiva, oferecendo cuidado e atenção, enquanto sempre desejam reciprocidade essencial. Esses indivíduos acreditam que seu parceiro traz sentido à sua vida e, em termos psicológicos, a essência do amor patológico não é mais o amor em si, mas sim o medo de serem inúteis se deixados sozinhos, abandonados ou não amados.

É importante destacar que o amor patológico envolve uma oscilação entre certeza ilusória e incerteza, desconfiança e possessividade, características que ocorrem em mulheres com baixa autoestima. Assim, as características dessa patologia baseiam-se na falta de controle sobre o ato de cuidar e na negligência dos interesses pessoais, mesmo na fantasia de ser amada.

Sophia et al. (2008) estipulam três critérios para identificar o perfil de alguém com amor patológico:

1. Sinais e sintomas de afastamento – quando o parceiro se mostra distante, física ou emocionalmente, ou por meio da ameaça de abandono, como o término do relacionamento, podem ocorrer os seguintes sintomas: insônia, taquicardia, tensão muscular, alternância entre períodos de letargia e intensa atividade;
2. O cuidado com o parceiro torna-se excessivo, ultrapassando o que o indivíduo desejaria. Frequentemente, o indivíduo reclama da atenção dedicada ao parceiro com muita frequência ou por períodos mais longos do que o inicialmente pretendido;
3. Muito tempo é dedicado ao controle das atividades do parceiro, em detrimento de interesses e atividades antes valorizados. Como o indivíduo passa a viver de acordo com as necessidades do parceiro, atividades que promovem a realização pessoal e o desenvolvimento profissional são negligenciadas, incluindo, por exemplo: cuidados com os filhos, investimentos profissionais, convívio social com amigos, etc.

Para confirmar o amor patológico (AP), é necessária uma avaliação diagnóstica que aborde aspectos psiquiátricos e histórico familiar, inclusive através da verificação do Padrão Geracional/Intergeracional dessa patologia, pelo estudo de duas ou três gerações de mulheres com AP.

Para melhor compreender por que algumas mulheres apresentam AP, utiliza-se também a teoria do apego de Bowlby (2006). Bowlby define o comportamento de apego como um conjunto integrado de sistemas comportamentais voltados para a conquista da segurança pessoal, com origem na infância. Ele também investiga os efeitos nocivos da separação de crianças pequenas de suas mães.

Após a formação do vínculo emocional seguro entre elas — ou seja, após o surgimento de uma forte relação afetiva — a criança sofre uma grande perda com essa separação, o que pode ser um fator que contribui para futuros problemas de relacionamento. Portanto, o autor cita que *“médicos de família, padres e leigos perspicazes sabem há muito tempo que poucos golpes no espírito humano são tão grandes quanto a perda de um ente querido”* (BOWLBY, 2006, p. 95).

O senso comum tradicional sabe que alguém pode ser devastado pela dor e morrer de imenso sofrimento, e também que um amante rejeitado é capaz de fazer coisas tolas ou perigosas, tanto para si mesmo quanto para os outros.

O DSM-IV (2003) define o transtorno de apego reativo na infância como: “*um tipo de apego social marcadamente disruptivo e inapropriado para o desenvolvimento na maioria dos contextos, começando antes dos cinco anos de idade*” (DSM-IV, 2003, pp. 83-84). Ele descreve um tipo de apego inseguro na infância que leva a relacionamentos desadaptativos na vida adulta.

O que exatamente é comportamento de apego? Bowlby (2002) o define como a busca e a manutenção da proximidade com outro indivíduo e a natureza dessa figura. O comportamento de apego é direcionado durante a infância e, portanto, tem inúmeros efeitos a longo prazo, persistindo na vida adulta.

Devido à imaturidade emocional, a pessoa que necessita de afeto (PA) evita correr riscos porque isso a deixa desconfortável. Eles vivenciam uma montanha-russa emocional onde cada sensação, mesmo a esperada, parece nova e excitante, e o diário do casal pode revelar momentos de tensão diante das reações de cada um a cada nova experiência. A dependência emocional se baseia no passado. Muitos casais entram em uma espécie de canibalismo mútuo, onde cada um devora o outro até desaparecer. Eles se absorvem como esponjas interconectadas, vendo apenas, através dos olhos do outro, “*metade da laranja*” (Barcelos, 1993).

Riso (2008) afirma que o amor patológico é visto como um vício afetivo com características de qualquer outro vício, mas com certas peculiaridades que ainda requerem estudo aprofundado. Ele sustenta que não existem campanhas de prevenção primária ou secundária, nem tratamentos altamente sistematizados para essa aflição. Em termos psicológicos, sabe-se muito mais sobre a depressão do que sobre seus hábitos, ou melhor, a ausência de amor é muito mais preocupante do que o afeto excessivo. Por que, então, é tão difícil identificar casos de amor patológico?

A dificuldade reside na própria concepção que a sociedade tem do amor e do papel da mulher. Essas concepções não são vistas como uma forma de funcionamento psicológico, embora sejam constantes, porque o mito do amor romântico dissemina a crença de que o amor só é verdadeiro quando uma pessoa não consegue viver sem a outra.

Mulheres que amam demais têm pouca consideração pela sua integridade pessoal dentro de um relacionamento romântico. Elas concentram sua energia em mudar o comportamento e os sentimentos de outras pessoas em relação a elas por meio de manipulação desesperada (NORWOOD, 2010). É bastante óbvio que seu comportamento sofre influências culturais e psicológicas, visto que, desde a infância, vêm de famílias disfuncionais onde desenvolvem padrões de codependência.

PADRÕES DE CODEPENDÊNCIA

Giddens (1993) afirma que mulheres codependentes são protetoras; elas precisam cuidar dos outros, mas, quase inconscientemente, têm a intuição de que essa devoção é mal recebida. Observa que “*codependente*” é um termo que, de certa forma, descreve o que antes era chamado, genericamente, de papel feminino.

Mellody (1995) diz que pessoas codependentes têm dificuldade em alcançar níveis adequados de autoestima, estabelecer limites funcionais, admitir e expressar sua própria realidade, atender às suas necessidades e desejos de adultas e vivenciar e expressar sua realidade de forma moderada. Elas são desprezadas,

atacadas ou abandonadas na infância; seus desejos e necessidades são ignorados pelos pais. Frequentemente, essas crianças nunca têm consciência de suas próprias necessidades porque elas nunca são atendidas, e crescem ignorando-as, passando a satisfazer os desejos e necessidades dos outros em vez dos seus próprios. Muito cedo, aprendem que não é apropriado expressá-las. Elas superestimam excessivamente a outra pessoa, esperando receber o mesmo em troca.

Em muitas famílias codependentes, a realidade da criança é desconsiderada a tal ponto que, para ser ouvida, ela precisa exibir comportamentos extremamente exagerados. Assim, na vida adulta, continua a se expressar de maneira exagerada, acreditando que essa é a única forma de obter atenção. Relacionamentos compulsivos impedem a exploração reflexiva da identidade própria (Giddens, 1993). O indivíduo codependente é alguém cuja identidade mais íntima é subdesenvolvida ou desconhecida, e mantém uma identidade falsa construída a partir de conexões de dependência com fontes externas.

Keleman (1996) explica que a distorção do amor pode ocorrer quando os pais tratam o filho como seu único objeto de apego e amor, ou quando buscam a realização pessoal por meio dos filhos como se vivessem para eles, e até mesmo quando usam os filhos de acordo com seus próprios interesses. Na vida adulta, essas crianças buscam reviver as mesmas experiências de amor que tiveram na infância, buscando ser amadas da mesma forma.

Cardella (1994) explica que mulheres que amam demais sentem-se constantemente ameaçadas de perder o amor de seus parceiros e, portanto, tendem a priorizar as necessidades deles, o que as impede de identificar e satisfazer as próprias necessidades, como faziam na infância com seus pais.

Ela também afirma que as mensagens tóxicas que essas mulheres recebem por meio da introspecção — mensagens que transmitem muitas concepções negativas sobre o amor — chegam até elas como conceitos, ideias, pensamentos e também por meio de modelos de relacionamentos amorosos, fazendo com que vivenciem o amor com grande ansiedade.

A autora afirma ainda que, quando uma criança recebe amor condicional, ou seja, vive em uma situação em que só recebe amor se este atender às expectativas de pessoas importantes em sua vida, ela cresce com a ideia de que essa é a única maneira de amar e ser amada. A consequência disso é o desenvolvimento de um padrão fixo de comportamento rígido e inautêntico, que se repete nos relacionamentos adultos na busca por amor e aceitação — um padrão geracional discutido posteriormente.

“Quando amar significa sofrer, estamos amando demais” (NORWOOD, 2005, p. 11). Com essa frase, a autora inicia seu livro, definindo “amar demais”, ou seja, o excesso de amor. Ela fala sobre o quanto uma pessoa deixa de viver a própria vida para fazer tudo pelo outro. Argumenta que se trata de uma questão cultural que envolve sofrimento por amor. Quando o comportamento e as crenças da outra pessoa não agradam, ainda assim são tolerados por amor.

Para a autora, a maioria das mulheres ama demais pelo menos uma vez na vida, apesar da dor e do sofrimento que esse amor excessivo causa.

É um fenômeno muito mais comum do que se imagina, levando muitas mulheres a acreditarem que essa é a essência dos relacionamentos íntimos. A relação entre amor e sofrimento é cantada e representada diariamente em nosso ambiente cultural, em novelas e canções, incutindo nas pessoas a ideia de que essa é a única maneira de amar. É importante destacar que essas mulheres que amam demais exibem comportamentos em que pensam apenas na outra pessoa, com

cuidado excessivo e uma crescente necessidade de dar amor e atenção ao parceiro. Isso leva algumas mulheres à dependência do relacionamento e do parceiro, que geralmente é desatento, inadequado e inacessível. Mesmo assim, a mulher que ama demais não consegue se distanciar dele e vive um ciclo repetitivo de sofrimento.

Norwood (2005) afirma que as mulheres que amam demais apresentam o seguinte perfil:

Amar demais não significa amar muitos homens, ou ser apaixonada com muita frequência, ou mesmo ter um grande e genuíno amor por alguém. Significa, na verdade, tornar-se obcecada por um homem e chamar isso de amor, permitindo que esse sentimento controle suas emoções e grande parte de seu comportamento, mesmo quando percebe que isso exerce influências negativas sobre sua saúde e bem-estar, e ainda assim se vê incapaz de se opor a ele. Significa medir a intensidade de seu amor pela quantidade de seu sofrimento (**NORWOOD, 2005, p. 21**).

No livro *“Mulheres que Amam Demais”*, da autora mencionada anteriormente, uma família disfuncional ou desajustada é descrita como aquela onde o diálogo não é praticado, os desejos e sentimentos não são expressos, os pais são separados ou a mãe é controladora, o pai é física ou emocionalmente ausente e não demonstra afeto, os pais têm vícios em álcool ou drogas, entre outras coisas.

A premissa básica, então, é que uma mulher que vivencia algumas dessas situações na infância está destinada, na vida adulta, a buscar homens com o mesmo perfil. Assim, pode-se presumir que uma mulher que ama demais está destinada (padrão geracional) a ser igual à sua mãe e, para que isso aconteça, ela precisa encontrar homens com o perfil do seu pai.

Norwood (1981) também explica que o antigo clichê psicológico de que todos tendem a formar relacionamentos com alguém semelhante aos seus pais é uma ideia falha. O que as pessoas realmente buscam não é um parceiro idêntico aos seus pais, mas sim um parceiro com quem possam se relacionar da mesma forma que se relacionavam com seus pais na infância — alguém com quem possam compartilhar os mesmos sentimentos e enfrentar os mesmos desafios. Isso lhes permite sentir-se confortáveis, pois estão em um ambiente familiar.

Para uma mulher que ama demais, isso representa um problema significativo, pois ela teve uma infância difícil, na qual suas necessidades não foram atendidas, e busca um parceiro que possa suprir essas necessidades. É com esse parceiro que a mulher tenta superar os sentimentos de não ser amada, desamparada e de dor que vivenciou na infância.

O VÍCIO COMO SINTOMA DA CODEPENDÊNCIA

Segundo **Norwood (1987)**, o relacionamento de uma mulher que ama demais com seu parceiro é semelhante ao de um viciado em drogas. Mellody (1995) também faz essa referência ao explicar que o principal sintoma da codependência é o vício. Esse vício pode ser gerado por uma substância ou um comportamento, pois alivia uma realidade insuportável e, portanto, consome cada vez mais o tempo da pessoa viciada, fazendo com que ela negligencie outros aspectos de sua vida. Além disso, o vício também acarreta consequências destrutivas e prejudiciais para o dependente, tanto psicológicas quanto físicas.

Então, a mulher que ama demais, portadora de AP (Percepção Associada do Amor), se relaciona com o parceiro cruel, desonesto ou indiferente como uma forma de se distanciar de seu vazio interior, seus medos, abandono e raiva. Isso porque

quanto mais difícil e conturbado o relacionamento, maior o distanciamento de seus próprios sentimentos de dor, e essa é uma maneira de camuflar o sofrimento interno. O dependente químico também apresenta esse comportamento e essa forma de camuflagem, que utiliza como uma válvula de escape para não entrar em contato com sentimentos dolorosos.

Enquanto o dependente químico sofre com os efeitos do abuso de substâncias, a mulher com AP sofre com os efeitos da tensão excessiva em que vive. Em ambos os casos, a dependência agrava o vício. Assim como o dependente químico não consegue abandonar a substância, a mulher que ama demais não abandona o parceiro. Isso acontece porque, por mais sofrimento que esse relacionamento cause, ainda é melhor do que estar sozinha, já que significa entrar em contato com as dores do passado e as do presente. Como prova disso, Norwood faz as seguintes observações:

[...] sem um homem a quem direcionar a atenção, entramos em um estado de abstinência, experimentando os mesmos sintomas físicos e psicológicos que acompanham a verdadeira abstinência do uso de drogas: náuseas, sudorese, tremores, batimentos cardíacos acelerados, pensamentos obsessivos, depressão, insônia, pânico e crises de ansiedade. Na tentativa de aliviar esses sintomas, retomamos nosso relacionamento com nosso último parceiro ou buscamos desesperadamente outro (NORWOOD, 1987, p. 38).

Portanto, pode-se pensar que o viciado em drogas busca aliviar seus sintomas localizando a substância química de seu interesse, desejo ou mesmo dependência (álcool, tabaco, cocaína, maconha, etc.). Nesse contexto, o amor patológico é uma dependência emocional doentia, tão destrutiva quanto a compulsão das pessoas por certos vícios, como drogas, sexo e comida. Uma pessoa que ama patologicamente busca satisfazer necessidades emocionais não atendidas em seus relacionamentos, tentando compensá-las (Carvalho, 2017).

O amor patológico parece manifestar-se mais em mulheres do que em homens porque, culturalmente, as mulheres consideram os relacionamentos românticos o objetivo e a prioridade primordiais em suas vidas (Fabichak, 2016). Uma pessoa que demonstra amor excessivo torna-se refém do parceiro e é incapaz de controlar suas emoções e sentimentos, o que leva a comportamentos obsessivo-compulsivos.

Perls (2002) afirma que as crianças ainda não são capazes de discernir entre o que lhes pertence e o que pertence aos outros porque seu ego ainda está em desenvolvimento e seus limites de contato são altamente permeáveis. Para manter a integridade do eu, elas cultivam uma espécie de falso eu, adaptando-se às necessidades dos pais e desenvolvendo uma postura na qual demonstram apenas o que se espera delas. Nesse sentido, Miller (1997) justifica a “necessidade” do falso eu com a seguinte afirmação: “O verdadeiro eu não consegue se desenvolver e se diferenciar porque não pode ser vivido” (MILLER, 1997, p. 23).

Tenório (2003) descreve as características de pessoas com personalidades orientadas para a abertura do limite de contato, segundo os conceitos da Terapia Gestalt. Para ele, essa personalidade se desenvolve ao longo da vida de acordo com os processos de interação organismo/ambiente e as formas de adaptação utilizadas, que levam à aprendizagem e ao estabelecimento desse padrão de comportamento. Com base nas características descritas pelo autor, é evidente que mulheres que amam demais possuem esse tipo de personalidade. Essas características são:

- Aceitam praticamente tudo o que lhes é imposto;
- Possuem uma noção introspectiva de "eu" e absorvem tudo o que é compatível com ela, sem fazer as transformações e assimilações necessárias;
- Adotam uma postura passiva em relação ao ambiente, submetendo-se aos outros para evitar conflitos e atender às expectativas alheias. Para isso, negligenciam as próprias necessidades;
- Têm dificuldade em fazer escolhas, pois não têm clareza sobre o que é bom para si mesmos e precisam da ajuda de outros para decidir;
- São emocionalmente dependentes dos outros, supervalorizando-os e temendo a solidão;
- Têm dificuldade em usar a agressão para transformar o ambiente, aceitando passivamente o que vem de fora, e suas tentativas de mudança são consideradas manipulação;
- Buscam engrandecer os outros na esperança de que estes façam o mesmo por eles, pois não possuem a capacidade de alcançar o que precisam de forma independente.

Miller (1997) descreve o seguinte que pode ocorrer em um lar disfuncional: abuso de álcool ou outras substâncias, abuso físico por um cônjuge e/ou filho, comportamento sexual inadequado dos pais em relação aos filhos, brigas e tensões constantes, pais competindo entre si ou com os filhos, pais exibindo atitudes e valores conflitantes, um dos pais incapaz de se conectar com outros membros da família, etc.

No entanto, a principal característica das famílias disfuncionais é que elas não têm um efeito típico sobre as crianças que crescem nelas. Essas crianças são prejudicadas, em certa medida, em sua capacidade de sentir e se relacionar com os outros. Quando jovens, essas crianças carecem de limites; elas não possuem uma maneira interna de se protegerem do abuso ou de evitar comportamentos abusivos em relação aos outros. Os pais precisam proteger seus filhos e impedi-los de sofrer abusos de outros (especialmente deles mesmos) (MELLODY, 1995, p. 41).

Miller (1997) justifica o amor patológico em mulheres adultas da seguinte forma: a criança está ciente dos conflitos em seu lar, mas se depara com a tentativa dos pais de negar seus problemas. Esses pais também se apresentam como emocionalmente inseguros, e seu equilíbrio depende de um comportamento específico ou da maneira de ser da criança. O autor afirma ainda que a criança, em sua fantasia de onipotência, absorve os problemas como se fosse responsável por eles.

Buscando garantir o amor dos pais, ela percebe claramente a situação e, desde muito cedo, se abstém de expressar suas próprias ansiedades. Tudo isso ocorre porque a criança possui uma grande capacidade de sentir o ambiente ao seu redor, embora não tenha consciência de todos os eventos que acontecem, pois ainda não consegue nomeá-los.

Contudo, em algum momento da vida, ela sente que esses eventos percebidos são compreendidos e nomeados, e são trazidos à consciência. A criança possui um grande poder de percepção e precisa expressar suas emoções sem que elas sejam ignoradas pelos pais. Essas famílias disfuncionais não validam os sentimentos e percepções de seus filhos porque o código do silêncio prevalece no lar.

Partindo da premissa de que, em um relacionamento, as atitudes de um parceiro são determinadas pela reação do outro, e que cada relacionamento possui características próprias que não se manifestam nos indivíduos quando estão em outros relacionamentos, é coerente afirmar que o fenômeno do amor excessivo resulta de experiências vividas tanto no passado quanto no presente, não apenas por mulheres, mas também por homens que, em relacionamentos conjugais, assumem significados que geram comportamentos típicos da codependência afetiva, conforme descrito por Melody (1995).

EM BUSCA DE UM AMOR SAUDÁVEL

Os efeitos neurobiológicos positivos do amor saudável ainda não fazem parte da vida emocional de muitos casais, pois, na maioria deles, apenas um dos parceiros ama intensamente. De cada dez relacionamentos amorosos, apenas um apresenta um amor saudável. Isso ocorre porque o amor doentio tem se tornado cada vez mais comum nos últimos tempos. Assim, a ideia de posse, de ter o outro como uma extensão e objeto de necessidade, é um gatilho que provoca a manifestação patológica (ADES, 2011).

Então, o que é amor saudável? Riso (2008) diz:

Você ou seu parceiro podem amar profunda e respeitosamente e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma tarde ensolarada, comer sorvete, dar um passeio, ir ao cinema, realizar uma pesquisa sobre seu tema favorito, assistir a palestras e viajar — em suma, você pode continuar sendo um ser humano completo e normal sem negligenciar seu parceiro e sem deixar de amar (RISO, 2008, p. 30).

Fromm (1990) faz a seguinte observação sobre o amor saudável:

O amor maduro é a união sob a condição de preservar a própria individualidade. O amor leva o homem a superar o sentimento de isolamento e separação, e isso lhe permite ser ele mesmo, manter sua integridade. No amor, ocorre o paradoxo de que dois seres se tornam um e, ainda assim, permanecem dois (FROMM, 1990, p. 166).

A afirmação de Branden (1988) é que, para amar o outro, o indivíduo precisa ter amor por si mesmo. Isso implica autoaceitação incondicional: é preciso respeitar, compreender e ouvir a si mesmo, reconhecendo tanto as próprias limitações quanto o seu potencial. O indivíduo deve se conhecer como um ser único e intrépido. Dessa forma, só se pode amar o outro quando se aprende a amar a si mesmo, pois uma pessoa que não se ama dificilmente acreditará que pode ser amada por outra. Aqueles que não se amam não podem aceitar e receber amor.

Cardella (1994) explica: “O amor está relacionado à doação, à disponibilidade e à preocupação com o bem-estar do amado, mas essas são atitudes que devem ser autênticas e livres de expectativas de retribuição” (CARDELLA, 1994, p. 51).

Para Bowlby (2002), o apego seguro se estabelece por meio de um vínculo calmo e emocional na infância com a figura primária de apego. Assim, observa-se que indivíduos seguros exibem interações mais seguras porque não encontraram dificuldades de relacionamento em suas vidas passadas e, portanto, sentem-se naturalmente mais orientados e confortáveis interagindo com os outros, uma vez que isso nunca se torna um problema.

Portanto, o funcionamento de uma personalidade saudável em qualquer idade reflete, em primeiro lugar, a capacidade do indivíduo de reconhecer figuras

adequadas que estejam dispostas e aptas a fornecer uma base segura e, em segundo lugar, sua capacidade de colaborar com essas figuras em relacionamentos mutuamente gratificantes.

O amor saudável é definido por Lino (2009) como “[...] *uma emoção agradável que proporciona acesso a um estado de tranquilidade e estabilidade emocional, permitindo o acesso a um relacionamento saudável e feliz entre duas pessoas [...]*” (LINO, 2009, p. 3).

Segundo Carvalho (2017), um relacionamento considerado “saudável” é aquele que promove o bem-estar do casal por meio de uma convivência emocional respeitosa, sem individualismo excessivo ou autossacrifício total em prol do outro.

Faur (2012) caracteriza o amor como uma energia restauradora, curativa e nutritiva, capaz de dar sentido, propósito e transcendência à vida.

O amor saudável vai além de mudanças neurobiológicas positivas em um relacionamento afetivo e, com base nisso, o que deve ser construído na relação é um espaço em que ambas as pessoas se sintam mutuamente confortáveis. De acordo com Bush e Bush (2015), a chave para um relacionamento saudável é a adoção de hábitos saudáveis baseados em gentileza, honestidade, ternura e atenção.

Casais saudáveis demonstram maturidade intelectual e valorizam o essencial: companheirismo, reciprocidade emocional e diálogo mútuo.

Riso (2014) argumenta que declarar-se emocionalmente livre promove o afeto sem opressão, afastando-se de relacionamentos nocivos e aproximando-se da ternura. Segundo a autora, decidir libertar-se da dependência emocional do parceiro é saudável porque não fomenta a frieza emocional, mas sim porque os relacionamentos interpessoais tornam a pessoa mais humana.

Além disso, na opinião de Riso (2011), “*No amor saudável, não há espaço para resignação, e se alguém precisa se reprimir ou se distrair para que a pessoa amada seja feliz, então está com a pessoa errada [...]*” (RISO, 2011, p. 6).

Cury (2014) acrescenta que casais saudáveis devem amar não com falta de inteligência, mas demonstrando um amor saudável. Em relação à relação entre o amor saudável e a falta de inteligência emocional, o autor oferece a seguinte reflexão:

Aqueles que se baseiam unicamente na emoção para sustentar relacionamentos correm o risco de ver seus sentimentos oscilarem entre o deserto e o gelo. Num instante, experimentam o brilho da paixão; no seguinte, a frieza da discórdia. Num instante trocam juras de amor; no seguinte, brigam por ciúme. Um relacionamento caracterizado pela falta de inteligência emocional é intensamente instável, enquanto um relacionamento saudável tem uma aura de aventura.

Num relacionamento caracterizado pela falta de inteligência emocional, um parceiro é especialista em exigir do outro, enquanto num relacionamento saudável, um parceiro é profundamente grato ao outro (CURY, 2014, p. 7).

Os relacionamentos interpessoais são vistos por Fabichak (2016) como tudo aquilo que uma pessoa faz e experimenta com prazer genuíno, com o objetivo de estimular os centros de produção de dopamina e oxitocina do cérebro. Exemplos incluem: a) trabalho voluntário; b) desenvolvimento profissional; c) viajar para lugares desconhecidos; e d) criar um blog.

Assim, esses exemplos de relações interpessoais, além de hábitos saudáveis (gentileza, honestidade, ternura e atenção), podem ser considerados manifestações positivas características do amor saudável. Por desencadearem prazer na relação

afetiva entre duas pessoas, contribuem para a formação de variações hormonais na ocitocina e na vasopressina, que regulam o sistema de recompensa do cérebro (Bush & Bush, 2015; Cardoso et al., 2014). Essas manifestações positivas do amor saudável, dentro do sistema neurobiológico, funcionam por meio da presença de dopamina, quando algo é obtido e o prazer é sentido ao obtê-lo, e por meio da geração de norepinefrina.

Como forma de prevenção para mulheres que saem de relacionamentos abusivos, Giddens (1993), em seu livro “*A Transformação da Intimidade*”, sugere a seguinte lista de regras, extraída de um manual de autoajuda destinado a ajudar mulheres a desenvolver relacionamentos heterossexuais mais satisfatórios:

[...]

- 1- Quando me pegar pressionando um homem que gosta de mim, falando tanto sobre mim que nem consigo fazer perguntas a ele, vou parar de agir dessa forma e avaliar se ele é o homem certo para mim.
- 2- Vou expressar meus sentimentos negativos e, quando perceber os dele, em vez de esperar que ele desenvolva seus sentimentos, vou parar, mesmo que isso signifique chatear meu parceiro.
- 3- Vou trabalhar para reparar meu relacionamento com meu ex-marido, atenta ao quanto me permito ser magoada, e não falarei dele como se eu fosse a vítima e ele o vilão.
- 4- Quando meus sentimentos estiverem feridos, direi ao meu parceiro como me sinto, em vez de ficar parado, impassível, fingindo que não me importo ou agindo como uma criança.
5. Quando perceber que estou preenchendo as lacunas (a zona morta do relacionamento), pararei e me perguntarei se meu parceiro tem se afastado de mim ultimamente. Se isso tiver acontecido, pedirei a ele o que preciso, em vez de fazer as coisas por conta própria.
6. Quando perceber que estou dando conselhos não solicitados ou tratando meu parceiro como uma criança, pararei, respirarei fundo e o deixarei resolver sozinho (a menos que ele peça minha ajuda) (GIDDENS, 1993, p. 210).

Embora considere as regras vergonhosas e contraproducentes, Giddens acredita que, se aplicadas com sucesso, elas podem ajudar a avaliar as ações de um indivíduo, fomentando assim maior autonomia e, ao mesmo tempo, exigindo respeito dos outros.

O imperativo da comunicação livre e aberta é a condição essencial para o relacionamento puro; o relacionamento é seu próprio fórum. Neste ponto, fechamos o círculo. A autoautonomia, a ruptura com a compulsividade, é a condição para o diálogo aberto com os outros. Esse diálogo, por sua vez, é o meio de expressar as necessidades do indivíduo, bem como o meio pelo qual o relacionamento se organiza reflexivamente (GIDDENS, 1993, pp. 210-211).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo, no âmbito da Psicologia Social, realizou uma discussão teórica de elevada profundidade acerca do conceito de Amor Patológico (AP), em busca de esclarecer ao máximo essa temática de forma a disseminar seus parâmetros, conceitos e aplicações fundamentais, auxiliando o trabalho das equipes de atenção psicossocial que frequentemente precisam atender indivíduos com AP.

Através de uma revisão narrativa de literatura, foram abordados a Busca da Patologia na Relação Amorosa, a Conceituação do Amor Patológico, os Padrões de

Codependência, o Vício como Sintoma da Codependência e, finalmente a Busca de um Amor Saudável.

Como se viu, o Amor Patológico verificado na fase adulta é muitas vezes originado do transtorno de apego reativo na infância (DSM IV, 2023), que pode ser definido como um tipo de apego social marcadamente disruptivo e inapropriado para o desenvolvimento na maioria dos contextos, começando antes dos 5 anos de idade.

O senso comum tradicional reconhece o caso de pessoas que são devastadas pela dor originada de relacionamentos amorosos, chegando a morrer de imenso sofrimento, além dos casos de amantes rejeitados que são capazes de fazer coisas tolas ou perigosas, tanto para si mesmo quanto para os outros.

Desta forma, considera-se que o objetivo do presente trabalho foi devidamente atingido, e espera-se que a discussão aqui apresentada possa auxiliar no trabalho de pesquisa sobre o Amor Patológico dentro das diversas áreas.

REFERÊNCIAS

ADES, 2011

APA - American Psychiatric Association. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**: DSM-IV. Porto Alegre: Artmed, 2003.

BARCELOS, 1993.

BOWLBY, 2002

BOWLBY, John. 2002.

BOWLBY, John. **Bindung: Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung**. München: Ernst Reinhardt Verlag, 2006.

BRANDEN (1988

BUSH E BUSH, 2015

CARDELLA, 1994

CARDOSO et al., 2014

CARVALHO, 2017.

CARVALHO, A. M. A.; POLITANO, I.; FRANCO, A. L. S. Vínculo interpessoal: uma reflexão sobre diversidade e universalidade do conceito na teorização da psicologia. In: **Estudos de Psicologia**, v. 25, n.2, pp: 233-240. 2008.

CURY, 2014

FABICHAK, 2016

FAUR, 2012

FREUD, 1910, p. 18

FREUD, 1937, p. 303

FROMM (1990)

GIDDENS, A. **A transformação da intimidade**. UNESP. 1993.

HALPERN-MEEKIN, S.; TURNEY, KRISTIN. Romantic Unions and Mental Health: The Role of Relationship Churning. In: *Journal of Health and Social Behavior*, v. 64, n. 2, out. 2022. <https://doi.org/10.1177/00221465221126091>.

KELEMAN. 1996.

LINO, 2009

MELLODY, P. **Enfrentando a codependência afetiva: o que é, como surge, como prejudica nossas vidas**. Rosa dos tempos. 1995

MILLER, A. O drama da criança bem dotada: Como os pais podem formar (e deformar) a vida emocional dos filhos. Summus. 1997.

MOITRA, M.; OWENS, S.; HAILEMARIAM, M.; WILSON, K.S.; MENSA-KWAO, A.; GONESE, G.; KAMAMIA, C.K.; WHITE, B.; YOUNG, D.M.; COLLINS P.Y. Global Mental Health: Where We Are and Where We Are Going. In: **Current Psychiatry Reports**, n. 25, pp: 301–311, 2023. <https://doi.org/10.1007/s11920-023-01426-8>.

NAIR, G.G.; SINHA, A. Romantic Dating Relationships Conflict & Mental Health among Young Adults. In: **The International Journal of Indian Psychology**, v. 11, n. 3, jul. 2023. ISSN: 2348-5396. <https://doi.org/10.25215/1103.203>.

NAVANEETHAM, P; KANTH, B. Effects of Personal Relationships on Physical and Mental Health among Young Adults: A Scoping Review. In: *The Open Psychology Journal*, v. 15, out. 2022. <https://doi.org/10.2174/18743501-v15-e2208180>.

NORWOOD, R. 1997.

NORWOOD, R. 2005.

NORWOOD, R. **Mulheres que amam demais**. Saraiva. 2010.

OPAS - Organização Panamericana de Saúde. **Mais de um bilhão de pessoas vivem com condições de saúde mental**: serviços precisam de ampliação urgente. 2 set. 2025.

PERLS (2002)

RISO, W. **Amar ou depender? Como superar a dependência afetiva e fazer do amor uma experiência plena e saudável**. Tradução Marlova Assef. L&PM. 2008.

SOPHIA, E. C.; CRESCENTE JUNIOR, J. A.; ZILBERMAN, M. L.; CORDAS, T. A. (2008). Amor Patológico. In: ABREU, C.N.; TAVARES, H.; CORDÁS, T.A. (Orgs.). **Manual dos Transtornos do Controle dos Impulsos**. 1a. ed. Artmed. 2008.

STANLEY, A.R; AGUILAR, T.A.; HOLLAND, K.M.; ORPINAS, P. Precipitating Circumstances Associated With Intimate Partner Problem–Related Suicides. In: **American Journal of Preventive Medicine**, v. 65, n. 3, pp: 385-394, set. 2023.

TENÓRIO (2003)

SOBRE A AUTORA

Luciana Gomes Martins – (*Doutora em Psicologia Social pela UKAR, 2023; Especialista em Arteterapia pelo Instituto Junguiano da Bahia, 2009; Especialista em Dependência Química pela UNIFESP/UNIAD, 2003; Bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário Paulistano, 2001*). Professora da FAI - Faculdade Irecê, Irecê, Bahia, luciana_gomes_martins@hotmail.com.